

突然使用甲状腺替代品可发生严重的心绞痛,心肌梗死或猝死,因此,应使用较低的起始剂量(一日 $25\mu\text{g}$ 或隔日 $50\mu\text{g}$),并且每4周增加1次剂量直至维持剂量。

可致心肌缺血的药物主要有:腺苷、苯丙胺、 β 受体阻滞剂(撤药时)、 β 受体激动剂、咖啡因、双嘧达莫、麦角胺、氟尿嘧啶、硝苯地平(短效)、茶碱、甲状腺素、维拉帕米、长春新碱和长春碱。

6 血栓栓塞疾病(TED)

动脉或静脉循环系统中血块在血管中突然栓塞可引起 TED。其中尤以静脉栓塞更常见,死亡率为 $1\%\sim 2\%$ 。深静脉血栓(DVT)常见于下肢和骨盆静脉,临床特征为伴有肿胀、发红(充血)、温热的小腿肚和大腿疼痛。治疗方法有恢复正常的血循环和抗凝血。若肺循环中部分静脉血栓(VT)破裂沉积可致肺栓塞(PE),表现为憋气、胸痛和萎陷。在动脉循环中,血栓可引起外周动脉(包括下肢和脑循环)闭塞,并致中风。

流行病学研究发现,口服避孕药(COCs)复方制剂可增加心血管疾病的危险,对血压,血小板功能,血凝,糖和脂质代谢均有影响。含 $50\mu\text{g}$ 以上雌激素和孕激素制剂因可致血栓性疾病而停用。

几乎所有的流行病学研究都显示,服用复方避孕制剂的妇女,DVT 或 PE 的危险增加。在最近的4项欧洲研究中,COCs 使 DVT 增加 $2.7\sim 4.5$ 倍,尤其在吸烟、肥胖、有家族 DVT 史的妇女中更高。

第三代孕激素去氧孕烯或孕二烯酮致血栓疾病危险增高。流行病学研究提示,这类孕激素致

VT 形成的发生率较第二代高2倍。目前不推荐 VT 高危妇女使用这类制剂,而只限于对其它 COCs 无法耐受的妇女使用。

近来的研究显示,激素替代疗法(HRT)使用者 VT 发生率增加 $2\sim 4$ 倍,研究指出在 HRT 停用后 VT 危险消失,且各种 HRT 制剂类型无明显临床差异。有 DVT 或 PE(家族或个人)史,严重静脉曲张,肥胖,创伤,手术或长期卧床者更易发生 VT。

COCs 服用者中风危险增加约2倍。其他患有高血压、糖尿病和有血栓史的病人发生率更高。

有几例关于口服溴隐亭用于产后抑乳而出现脑血管疾病的报道。可能是因脑血管痉挛引起,且与病人曾患有高血压以及与其他麦角类衍生物合用有关。因此,产后服用溴隐亭的妇女应仔细监测血压,使用抗高血压药物时应特别注意。

7 瓣膜疾病

1988 年报道有1例病人过量摄入 5-HT 拮抗剂麦角胺后发生主动脉瓣膜疾病。后来又有报道2例服用酒石酸麦角胺治疗偏头痛的病人出现心脏瓣膜疾病,并需要行瓣膜置换手术。

最近发现,食欲抑制剂可致二尖瓣、主动脉瓣和三尖瓣疾病。服用芬氟拉明-芬特明的病人出现心瓣小叶回流和增厚。二尖瓣拉长、增厚、变白和发亮,与长期使用麦角胺后的特征类似,可能与 5-HT 的影响有关。几项研究均支持食欲抑制剂与心瓣疾病有关。英国已停止芬氟拉明和右旋芬氟拉明在临床上的使用。

刘 萍编译 边 强审校

部分中草药引起的药物相互作用[Anon. J Pharm, 2000; 264: 173]

部分中草药可增强或对抗某些常用药物的作用。

对患有凝血功能障碍的病人,若正在服用抗凝剂或正在等待手术,应避免服用丹参、当归、番木瓜和大蒜,因为合用后会使得 INR 增加。而华法林与 Devil's claw (野毛茛;或角胡麻属)合用可致紫癜。阿司匹林应避免与银杏合用,否则易发生自发性眼前房出血;银杏和华法林合用可增加颅内出血机会;银杏与对乙酰氨基酚或麦角胺或咖啡因合用可致硬膜下血肿;银杏与噻嗪类利尿剂合用可增加高血压,但可能不只是由银杏引起。人参与华法林合用后也可使 INR 升高。与苯乙肼合用,银杏可致躁狂,头痛和震颤,人参还可增加乙醇的清除率,而西伯利亚人参可增加地高辛浓度。

金丝桃科植物可与许多药物发生相互作用,特别是

与 5-HT 再摄取抑制剂合用时,可能会产生轻微的 5-HT 综合征,如出现胃肠道不适,精神状态改变,震颤和头痛等。此外,金丝桃科植物还可与地高辛、环孢素及复方口服避孕药发生相互作用。

此外,辣椒胡椒属可消除 P 物质,与 ACE 抑制剂合用后可致咳嗽;辣椒属还可增加茶碱的吸收及其生物利用度。

对中草药产品须注意的另一点是:成药中可能含有其它药物和重金属成分。在对台湾8个医院的2609份传统中药进行分析时发现,24%含有其它药物成分,最常见的是咖啡因、对乙酰氨基酚、吲哚美辛、氢氯噻嗪和泼尼松龙。此外,还含有苯二氮䓬类和非甾体类抗炎药物。在美国对251种亚洲中草药专利产品进行分析发现,其中24种含铅,36种含砷,35种含汞。

刘 萍 边 强 摘